斜视诊疗指南：内容提取与拟定流程

2026 · 指南 · DOI：原文未提供DOI

常见斜视诊断、屈光/弱视处理、手术时机与特殊病因；8页主PPT为速查摘要，详细罕见类型另见提取表。

strabismus-01 基本病史与检查

记录起病、恒定/间歇、复视/头位、远近变化和控制；询问儿童围产史及获得性斜视神经/眶病/外伤/全身病。检查远近视力、外眼/前节/眼底/眼压。

2026 PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：觉功能的建立，减轻斜视相关心理社会负担，提高患者生活质量。为规范斜视的诊断治疗，制定本指南。一、斜视的基本检查（一）询问病史应询问斜视起病或被发现的时间、发病形式、发病规律（恒定性/间歇性）、是否伴复视、异常头位、斜视在不同注视距离（远/近）时的变化、斜视频率及控制能力。儿童患者需了解有无相关的发病诱因，包括母亲妊娠史、是否早产、难产、出生窒息或低出生体重等。获得性或非共同性斜视需重点询问发热、外伤、颅脑或眼眶疾病、甲状腺疾病、糖尿病、高度近视、全身用药及相关诱因。还应了解既往屈光矫正、弱视治疗、近距离用眼情况、双

strabismus-02 儿童散瞳验光

6岁以上且无内斜，初验可1.0%环喷托酯；残余调节/不稳改1.0%阿托品眼膏或凝胶。内斜一般1%阿托品；≥12岁且无调节相关异常可酌用复方托吡卡胺。

2026 PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：分别记录偏斜头位和头位正位时的视力。儿童斜视患者应进行睫状肌麻痹验光。6岁以上且不伴内斜视的儿童，初次验光可选用1.0%环喷托酯滴眼液，若检出残余调节较多或屈光度数不稳定，应改用1.0%阿托品眼膏或凝胶充分麻痹睫状肌后再次验光。对于内斜视患儿，一般采用1%阿托品眼膏或凝胶充分麻痹睫状肌后验光；12岁及以上、无调节相关内斜视及调节功能异常者，可酌情使用复方托吡卡胺进行散瞳验光。所有患者均应常规行外眼、眼前节、眼底及眼压检查，排除器质性病变对诊断和治疗决策的影响。二、斜视的专科检查（一）眼球运动功能检查眼位检查应包括遮

strabismus-03 眼位与双眼视

遮盖/三棱镜定量，远距5或6
m，近用调节视标；九诊断眼位、运动、Worth/Bagolini/远近立体视。疑麻痹/限制时牵拉/收缩试验及按需影像。

2026 PDF2–3、19–20；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：器质性病变对诊断和治疗决策的影响。二、斜视的专科检查（一）眼球运动功能检查眼位检查应包括遮盖-去遮盖试验、交替遮盖试验、三棱镜交替遮盖试验和角膜映光法。三棱镜交替遮盖试验是临床常用的定量测量斜视度的方法；角膜映光法和Krimsky法适用于低龄、不配合、单眼视力差或伴有严重眼球运动障碍患者。测量视近斜视度时应使用调节性注视视标，测量视远斜视度时宜使用5m或6m远距视标。诊断眼位检查应记录原在位、水平、垂直及斜向注视时的斜视度和眼球运动情况，以明确共同性或非共同性斜视的2诊断，辨识受累肌肉，并为手术设计提供依据。通过观

strabismus-04 共同治疗原则

先矫正屈光不正和治疗弱视；手术时机综合类型、斜视稳定性、年龄、双眼视、复视与全身情况。无症状隐斜一般不干预。

2026 PDF3–4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：疾病。治疗目标包括改善眼位和外观，恢复或保护双眼视觉功能，治疗或预防弱视，消除复视和异常头位，进而改善生活质量。治疗前应优先矫正屈光不正和治疗弱视。手术时机需综合斜视类型、斜视度稳定性、年龄、双眼视觉状态、复视症状及全身情况审慎决定。3（一）隐性斜视隐性斜视是一种潜在的眼位偏斜，能在融合控制下保持双眼单视。分为外隐斜、内隐斜、上隐斜、旋转隐斜。1.诊断症状：易视疲劳。内隐斜较外隐斜更容易引发症状。体征：交替遮盖时可见眼球移动。单眼遮盖去遮盖试验，注视眼始终保持不动，偏斜眼遮盖时出现眼位偏斜，去遮盖后即刻回至正位。2

strabismus-05 先天内斜

生后6个月内持续内斜；通常>40△。<4月龄间歇、可变或<40△密切随访。验光<+2.00 DS可不配镜，≥+2.00 DS戴镜观察3～6月；建议24月龄前手术。

2026 PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：戴镜观察3～6个月。单眼恒定性内斜视患者需行屈光矫正联合对侧眼遮盖或应用阿托品压抑治疗，待建立交替注视后再行手术。建议在24月龄前进行手术，以恢复双眼周边融合功能；诊断明确且斜视度稳定者可酌情提早手术。主要的术式为双内直肌后退术或联合外直肌缩短术，也可行单眼的一退一缩术；合并斜肌功能异常者应同期解决。其他治疗方式包括肉毒毒素注射，可使大度数先天性内斜视大幅度减少斜视度，对小度数也有矫正作用。肉毒毒素注射为暂时性的治疗，疗效维持半年左右，部分需重复注射。2.调节性内斜视调节性内斜视分为屈光调节性内斜视和高AC/A型内

strabismus-06 屈光调节性内斜

1%阿托品验光后远视足矫，有弱视行遮盖；5岁前每6月复查验光/眼位/矫正视力，5岁后每年。转部分调节或合并垂直斜尽早手术。

2026 PDF5–6；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：光调节性内斜视屈光调节性内斜视十分常见，发病年龄集中在2～3岁。诊断：①病史：患儿发病年龄多数在6个月～7岁，平5均2.5岁，发病初期多表现为间歇性，后逐渐进展为恒定性。②伴有远视性屈光不正，多介于+3.00DS～+6.00DS。少数可大于+6.00DS。③发病初期斜视度不稳定，视近与视远斜视度相等。④AC/A值正常。⑤戴全矫的远视眼镜后眼位正位。治疗：1%阿托品睫状肌麻痹验光后配戴足矫的眼镜。单眼弱视患者应行遮盖治疗。5岁前，每6个月复查睫状肌麻痹验光、眼位和矫正视力情况，据此调整配镜处方；5岁后每年复查。若转为

strabismus-07 高AC/A及部分调节性

高AC/A：视近内斜视度大于视远10△、AC/A>6:1；双焦点远视足矫，近附加+1.50～+3.00 DS。部分调节：全矫后残余内斜>10△，治弱视后手术残余角。

2026 PDF6–7；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：疗。（2）高AC/A型内斜视诊断：发病年龄多集中在6个月～7岁，多为轻度远视眼，视近内斜视度大于视远10△，AC/A超过6:1，可伴单眼弱视。治疗：配戴双焦点眼镜，充分矫正远视性屈光不正，使视远眼位正位或小于+10△；视近下加+1.50DS～+3.00DS。有弱视者行遮盖治疗。若保守治疗效果不佳者，可手术治疗，根据视近斜视度进行三棱镜适应性训练。常选择双内直肌后退，可联合后固定缝线术。（3）部分调节性内斜视诊断：患儿发病年龄多在1～3岁，早于屈光调节性内斜视。屈光状态以中度远视性屈光不正为主。常伴散光及屈光参差。屈

strabismus-08 急性内斜与术后异常

急性共同性内斜首先完善神经/影像排除颅内器质病；外斜术后内斜伴明显复视及严重外转受限，警惕肌肉滑脱、及时探查。

2026 PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：危险信号

原文锚点：一类以急性发生、伴同侧复视为特征的共同性内斜视，多与长期近距离用眼超负荷有关，近年来发病率呈显著上升趋势。治疗：首先完善神经系统及影像学检查，排除颅内器质7性疾病。治疗方案根据患者病程、斜视度、融合功能情况制定个体化制定。①保守治疗：多用于发病早期、斜视度小、融合功能较好的轻症患者，配戴三棱镜消除复视，部分患者可恢复正常眼位与双眼视功能；②肉毒毒素眼外肌注射：适合轻中度斜视、病程较短者；③手术治疗：适用于斜视度大、保守治疗及肉毒毒素疗效欠佳、病程迁延者。（2）知觉性内斜视平均发病年龄2岁。患儿出生后早期单眼盲或视力

strabismus-09 间歇外斜分型

基本型远近差<10△；分开过强远>近≥15△，遮盖一眼30～60 min仍大；集合不足近>远≥15△；类似分开过强型遮盖后近角增大。

2026 PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：要参考指标。分型：①基本型：视远、视近斜视度相近，相差＜10△。AC/A值正常。②分开过强型：视远比视近斜视度大，相差≥15△；遮盖一眼30～60分钟后，视远斜视度仍然大于视近。③集合不足型：视近斜视度大于视远，相差≥15△。AC/A值9低于正常。④类似分开过强型：初次检查时视远斜视度比视近大，但遮盖一眼30～60分钟后，视近斜视度增大，与视远相近或更大.治疗：治疗应依据控制力、发作频率、斜视度和双眼视功能综合决定。①非手术治疗：对于控制良好的间歇性外斜视患儿，可随访观察，监测立体视功能变化。②手术治疗：对于发作频

strabismus-10 间歇外斜决策

控制良好可观察立体视；频发、评分升高、每日较长时间外斜、近立体下降/远立体丧失/融合范围减少 → 考虑手术。未给统一评分手术切点。

2026 PDF10；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：视度和双眼视功能综合决定。①非手术治疗：对于控制良好的间歇性外斜视患儿，可随访观察，监测立体视功能变化。②手术治疗：对于发作频繁、量化评估评分升高、每日较长时间外斜、近立体视下降、远立体视丧失或融合范围明显减少者，应考虑手术。常用术式包括双眼外直肌后退术、单眼或双眼外直肌后退联合内直肌缩短术，小角度者可考虑单眼外直肌后退术，需告知复发和再次手术可能。（2）恒定性外斜视指融合功能不能控制双眼视轴平行、眼位始终呈外斜视的状态。1岁后发病或由间歇性外斜视失代偿进展而来。诊断：幼年或成年发病。斜视度大而稳定。多数视力或矫正

strabismus-11 先天/恒定外斜

先天外斜推荐12～18月龄手术，不稳可延至18～24月龄；先矫屈光/治弱视。恒定外斜以手术为主，可交替注视者及时手术。

2026 PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：②治疗弱视，待双眼能够交替注视后可考虑手术治疗；③手术治疗：虽然早期手术很少能获得正常的双眼视功能，但仍然是适应症。推荐12～18月龄手术，若斜视度不稳定，手术可推迟至18～24月龄。延迟至2岁后手术难以建立融合。2.共同性外斜视（1）间歇性外斜视是亚洲儿童最为常见的外斜视类型，患病率在各类共同性斜视中占首位。平均发病年龄4～5岁。诊断：远眺、疲劳、注意力不集中或患病时常表现出外斜视。部分患者在明亮处有单眼畏光的特点，喜闭上一只眼睛。多数患者有远、近立体视觉的受损。控制能力可通过PEDIG控制评分、Newcastl

strabismus-12 A-V与集合不足

V型上/下转差≥15△，A型差≥10△；结合斜肌功能决定手术。集合不足近点>6 cm，先集合训练/棱镜，症状重且无效可考虑手术。

2026 PDF11–12；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：或从事近距离活动时需要闭上一眼以避免复视的现象，与视近时外隐斜或外斜视有关。视近外隐斜比看远大，视近的正融像性集合不足，集合近点＞6cm。治疗：集合训练通常有效，成人的训练效果不如儿童。其他非手术治疗包括棱镜阅读镜。若存在明显的视远外斜、症状较重，集合训练、使用棱镜阅读眼镜效果不佳，可考虑手术。手术方式多采用外直肌后徙术（若有视远外斜视）和/或内直肌缩短术（若有视近外斜视）。（六）与衰老和近视相关的获得性斜视与眼外肌和Pulley复合物衰老相关的斜视形式，包括分开不足、松眼综合征和近视固定性斜视（“重眼”综合征）。

strabismus-13 麻痹/限制性路径

先找病因并处理原发病，必要影像；未稳用遮盖/Fresnel棱镜/肉毒毒素。多数待斜视度稳定约6月手术；肌断裂/眶嵌顿等急诊可早期介入。

2026 PDF7、11、13–14；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：天性麻痹性斜视应首先明确病因并处理原发病；病情未稳定前可行遮盖、Fresnel三棱镜或肉毒毒素对症治疗。多数病例待斜视度稳定约6个月后再行手术；若影像学证实肌肉断裂、眶壁嵌顿或需急诊处理的神经或眶部损伤，可早期介入。（八）特殊类型斜视1.分离性垂直偏斜（DVD）又称交替性上隐斜，特点为不遵循眼球运动Hering法则，当交替遮盖时遮盖眼呈现上漂，去遮盖后眼位缓慢回到注视位合并内旋。Bielschowsky现象阳性。治疗：首先矫正屈光不正和治疗弱视，配镜时可以用光学方法转换注视眼，即将上漂明显眼转为注视眼，以抑制或减少

strabismus-14 特殊病因与慎用

Duane第一眼位无斜及代偿头位无需治，有则手术、慎加强；Brown查因后3～6月保守无效再考虑手术；甲状腺眼病联合内分泌，不能仅调眼位。

2026 PDF15–17；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：眼上转受限伴不同程度的水平注视受限。治疗：以手术为主，多采用眼外肌减弱术，目的是改善眼位与头位，但无法恢复眼球运动。4.Duane眼球后退综合征因先天性展神经发育异常伴动眼神经异常支配所致的眼球运动障碍。临床分三型：Ⅰ型：受累眼外转受限、内转无明显限制，可合并内斜视。Ⅱ型：受累眼内转受限、外转无明显限制，可合并外斜视。Ⅲ型：受累眼内外转均受限，可以无斜视或合并内斜视或外斜视。诊断：受累眼外展受限，内转时睑裂明显缩小，眼球后退，外转时睑裂开大。有明显代偿头位。被动牵拉试验阳性。治疗：第一眼位无明显斜视和代偿头位者无需

strabismus-15 其他病因提示

松眼/重眼可行MRI评估；重眼通常需手术且先查视网膜。重症肌无力以神经内科治疗为主，全身良好、无危象、症状及角度稳定6～12月才慎重手术。

2026 PDF12–13、18；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：激或单纤维肌电图等。治疗以神经内科病因及规范的药物治疗为主。伴明显斜视者，需在全身情况良好、无危象风险、症状及斜视度稳定6～12个月后，方可慎重考虑斜视矫正术。（九）中枢性麻痹性斜视：以治疗原发病为主。（十）眼球震颤眼球震颤为非自主性、节律性眼球摆动，可分为冲动型、钟摆型以及水平、垂直、旋转或混合型。患者常通过转头、歪头或下颌上抬/内收寻找中间带，以减轻眼震并提高视觉质量。治疗包括矫正屈光不正、三棱镜改善异常头位和手术治疗。手术目的为改善代偿头位、提高视觉质量并减轻眼震程度，通常需结合年龄、视觉发育和头位稳定性决定

strabismus-16 手术前评估

九眼位定量、双眼视、按需CT/MRI/超声；麻醉诱导后、切口前牵拉试验。按年龄/麻醉/疾病做全身检查；儿童全麻需麻醉评估及儿科会诊。

2026 PDF19–20；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：动及单眼各方向运动，以判定麻痹性斜视受累肌肉及A-V现象，为诊断和手术设计提供依据。19（3）被动牵拉试验：麻醉诱导后，切口制作前实施，以鉴别麻痹性与限制性因素。（4）双眼视觉功能检查：①Worth四点灯试验；②同视机；③远、近立体视图谱检查。（5）眼外肌影像学检查：根据不同病因选择眼眶CT、MRI及超声进行检查。3.全身检查：应根据年龄、麻醉方式和基础疾病，完善血常规、凝血、肝肾功能、血糖、传染病筛查、心电图及胸部影像等检查。儿童全麻手术应进行麻醉科评估及儿科会诊。（二）术前准备术前3日预防性应用抗生素滴眼液，每

strabismus-17 术前预防用药

本2026指南规定术前3日预防性抗生素滴眼液，每日3～4次；具体品种和每次滴数原文未明确。与2025儿童共识的表述分开保存。

2026 PDF20；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：血常规、凝血、肝肾功能、血糖、传染病筛查、心电图及胸部影像等检查。儿童全麻手术应进行麻醉科评估及儿科会诊。（二）术前准备术前3日预防性应用抗生素滴眼液，每日3～4次。术前应清洁睫毛、眼睑及周围皮肤，并按眼科手术标准完成皮肤及结膜囊消毒。（三）手术实施1.麻醉方式：12岁以下患儿通常选用全身麻醉；12岁及以上患者可根据配合程度、手术复杂性和患者及家属意愿选择麻醉方式。2.手术方式：根据斜视类型及斜视度，设计手术方式及手术量，部分复杂病例或术后眼位不确定性高者可采用可调缝线技术。手术应严格遵守无菌操作。术毕，结膜囊涂抗

strabismus-18 麻醉与术后管理

<12岁通常全麻；≥12岁按配合/复杂性及意愿选择。术后常规抗生素，按炎症联合NSAID/激素；具体统一剂量与禁忌清单未明确。

2026 PDF20–21；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：滴眼液，每日3～4次。术前应清洁睫毛、眼睑及周围皮肤，并按眼科手术标准完成皮肤及结膜囊消毒。（三）手术实施1.麻醉方式：12岁以下患儿通常选用全身麻醉；12岁及以上患者可根据配合程度、手术复杂性和患者及家属意愿选择麻醉方式。2.手术方式：根据斜视类型及斜视度，设计手术方式及手术量，部分复杂病例或术后眼位不确定性高者可采用可调缝线技术。手术应严格遵守无菌操作。术毕，结膜囊涂抗生素眼膏和糖皮质激素滴眼液或眼膏。（四）术后处理201.术后用药：术后常规滴用抗生素滴眼液，预防结膜切口感染。根据眼部炎症反应，必要时联合非甾体

strabismus-19 规律长期随访

术后1天、1周、1月、3月、6月；后按恢复每6～12月一次，持续至视觉发育成熟，即使早期眼位良好也不终止。

2026 PDF21；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：及炎性反应。2.术后随诊：建立规律随访计划，术后1天、1周、1个月、3个月、6个月复查；此后根据眼位及视功能恢复情况，每6～12个月随访一次。即使术后早期眼位矫正良好、视功能恢复理想，仍需坚持长期规律随访，直至患者视觉发育完全成熟，旨在有效规避远期眼位漂移、双眼融合功能衰退、隐匿性斜视复发等问题。21

strabismus-20 罕见类型补充

DVD合并水平斜视时一眼同次一般不超两条直肌（显微血管分离可三条）；纤维化手术改善眼/头位不能恢复运动；Moebius可手术；中枢麻痹先治原发病。

2026 PDF14–16、18；推荐等级：原文未明确；类别：特殊类型

原文锚点：将上漂明显眼转为注视眼，以抑制或减少上漂。目前手术只能在一定程度上改善DVD。合并水平斜视者同时予以矫正，但一眼同次手术不得超过两条直肌。行显微血管分离术时，可行三条肌肉手术。2.间歇性外斜视合并调节性内斜视多在2岁前发病，内外斜视共存。具有间歇性外斜视与调节性内斜视的双重特点。常合并高度远视，AC/A正常或低于正常，斜视度变化大，戴镜后内斜视消失，双眼单视功能不良，常伴视疲劳等症状。治疗：首先睫状肌麻痹验光配镜，治疗弱视。对于小度14数外斜视（＜20△）、间歇性、具有一定的双眼单视及立体视者，可暂缓手术；如频发外

strabismus-21 眼震与视网膜性复视

眼震先屈光矫正，棱镜或手术改善头位/视觉；视网膜注视点易位需影像与专门试验，融合困难时斜视手术成功率低。

2026 PDF18–19；推荐等级：原文未明确；类别：特殊类型

原文锚点：伴有视物变形、视物变小或变大等表现。可通过开灯-关灯试验、视标框试验及眼底影像辅助判断。治疗：最有效的治疗方法是采用单眼雾视法，生成中心凹盲点而成功消除中心凹冲突。如果通过同视机或三棱镜不能满意地消除或减少主观复视，则斜视手术成功率低。四、斜视的手术操作规范（一）术前检查1.一般检查（1）视力及验光检查：分别检查裸眼及矫正的远、近视力，明确屈光状态。（2）眼压：异常者需综合评估，审慎把握手术时机。（3）外眼、眼前节、眼底检查：排除器质性病变，行眼底照相客观评估眼球旋转状态。2.斜视专科检查（1）眼位：联合应用角膜映

strabismus-22 缺项与原文边界

无统一正式推荐等级、跨类型手术量表、所有药物剂量/禁忌或单一危险评分；间歇外斜远近差10～<15△的分类边界未单独说明，不补编。

2026 PDF9–10、20–21；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：制能力可通过PEDIG控制评分、Newcastle控制评分、LACTOSE评分等量化评估，并作为手术决策的重要参考指标。分型：①基本型：视远、视近斜视度相近，相差＜10△。AC/A值正常。②分开过强型：视远比视近斜视度大，相差≥15△；遮盖一眼30～60分钟后，视远斜视度仍然大于视近。③集合不足型：视近斜视度大于视远，相差≥15△。AC/A值9低于正常。④类似分开过强型：初次检查时视远斜视度比视近大，但遮盖一眼30～60分钟后，视近斜视度增大，与视远相近或更大.治疗：治疗应依据控制力、发作频率、斜视度和双眼视功能综

拟定流程（整理表达）

1. 病史、眼位、视力与屈光

全面眼检查/双眼视；儿童麻痹验光；急性/非共同或外伤 → 先病因与必要神经/眶影像。

2026 PDF1–3、7–8、11、13–14、19–20

2. 先屈光与弱视处理

足矫及弱视治疗后，重新测量远近角和控制/立体视，再按内/外/特殊分支决策。

2026 PDF3–7

3. 内斜分支

全矫正位→调节性；残余>10△→部分调节性评估手术；高AC/A>6:1→双焦点等；先天按年龄时机。

2026 PDF4–7

4. 外斜分支

控制良好→观察；频率/评分恶化或立体视下降→考虑手术；恒定/先天按对应时机。

2026 PDF9–10

5. 麻痹/特殊分支

病因治疗；一般角度稳定约6月再手术；眶嵌顿/肌断裂等可早介入；各综合征见专门条目。

2026 PDF7、11–19

6. 围术期与长期复查

按2026术前方案；术后1天、1周、1/3/6月，后6～12月；术后异常受限+复视及时排滑脱。

2026 PDF7–8、19–21

原文缺项与核对事项

PDF自带页码1–25，无期刊页码和DOI；不自行补署发布机构或文献真实性认证。

2026术前预防抗生素与2025儿童共识差异分别标注。

8页PPT为重点速查；罕见类型与眼震/视网膜性复视完整条目保留在提取表。